Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Dyspnée / Désaturation

Gêne respiratoire ou SpO2 basse : asseoir, mesurer, alerter. L'oxygène est mis en route et réglé par l'IDE ou sur prescription. Adulte et enfant (IME).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · lutte pour respirer, bruits respiratoires, lèvres bleues, ne peut plus parler, somnolence ou agitation inhabituelle, douleur thoracique.

1 · Je sécurise

- Je l'**assois** ou la mets demi-assise, comme elle respire le mieux ; je desserre les vêtements.
- Je reste avec elle et je la rassure.
- Pendant un repas ou en buvant : **fausse route** ? → « Fausse route / Obstruction des voies aériennes ».
- Trachéotomie : fiche « Trachéotomie : canule bouchée ou retirée ».

2 · J'observe et je mesure

- **SpO2** au repos, **FR** sur 1 minute, pouls, TA, T°.
- **Cible de SpO2** fixée par le médecin (insuffisant respiratoire chronique) ? Voir le dossier.
- Tirage, ailes du nez, sifflements, encombrement, couleur ; peut-elle parler ?
- Douleur thoracique, fièvre, toux, jambe gonflée ; début brutal ?
- Sous O2 prescrit : lunettes en place ? tuyau coudé ou débranché ? appareil en marche ?

3 · J'agis

- O2 prescrit, lunettes déplacées : je les **remets** (AS/AP) **sans toucher au débitmètre**.
- Encombrement : aider à tousser, à se moucher ; trachéotomie cicatrisée : aspiration (AS/AP formé).
- Inhalateur « si besoin » : aide à la prise (AS/AP) **après validation de l'IDE** ; PAI asthme : je l'applique.
- Je recontrôle SpO2 et FR jusqu'à l'avis de l'IDE ou l'arrivée des secours.

Je ne fais pas

- **Mettre en route l'O2 ou changer le débit** (IDE ou prescription).
- Allonger à plat une personne qui respire mal.
- Faire boire ou manger pendant la gêne.
- La laisser seule ou attendre que « ça passe ».

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Lutte, bruits, lèvres bleues, **ne peut plus parler**.
- Somnolence ou agitation inhabituelle ; douleur thoracique.
- Chiffre d'alerte et **IDE non joignable** tout de suite.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- SpO2 **< 90 %** ou **sous la cible** ; FR **< 10 ou > 25/min** : **sans délai**.
- Gêne nouvelle, toux, fièvre, encombrement, même SpO2 normale.
- Enfant (IME) : geignement, tirage, ailes du nez, enfant mou ; PAI d'abord.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, SpO2, FR, position, O2 (débit affiché, non modifié), qui a été prévenu.
- Après l'épisode : fièvre, toux, encombrement qui s'installe → IDE.
- Fausse route récente : la signaler (risque d'infection pulmonaire).

Mention de sécurité

Assise, mesurée, jamais seule. L'oxygène se met en route et se règle par l'IDE ou sur prescription : je ne touche pas au débitmètre.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SRLF-SFMU, conférence de consensus oxygénothérapie (2024, AFMU 2025) ; ARS IDF/SGGIF, fiche difficulté respiratoire (2016) ; ARS IDF/STARAQS (2023) ; arrêté du 10/06/2021 (référentiel AS, module 4) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap (01/2025).

Réf. DOTR-AS-DYSP | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature